

Kwalifikacja *do STPP*

Nie każdy pacjent jest odpowiedni dla intensywnej, ograniczonej w czasie pracy dynamicznej. Pięć kryteriów pozytywnych, cztery wykluczenia i próbna interpretacja.

CZAS: 30 min Sesje 1–3; decyzja o rozpoczęciu STPP vs inna forma pracy

ŹRÓDŁO: Malan (1976); Davanloo (1990)

JAK UŻYWAĆ

Oceniasz, czy pacjent jest odpowiedni dla STPP, według kryteriów Malana i Davanloo. Sprawdzasz pięć cech pozytywnych (jakość wcześniejszych relacji, motywację do rozumienia, refleksyjność, tolerancję afektu, możliwość wyłonienia jednego fokusu) oraz wykluczenia względne. Stosujesz **próbna interpretację**: w 1.–2. sesji wskazujesz drobną obronę i obserwujesz reakcję — ciekawość vs załamanie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Kierowanie wszystkich na STPP grozi dekompensacją u nieprzygotowanych pacjentów; odrzucanie wyłącznie na podstawie diagnozy odbiera szansę odpowiednim. Kwalifikacja chroni obie strony i zwiększa skuteczność. Kluczowa jest **tolerancja afektu i refleksyjność** — pacjent musi unieść intensywne emocje bez załamania i potrafić spojrzeć na siebie z zewnątrz. Nie diagnozuj na podstawie jednej rozmowy: w pierwszej sesji pacjent bywa defensywny i pokazuje mniej, niż ma.

01 ✓ Pięć kryteriów pozytywnych

Zaznacz, które kryteria pacjent spełnia — niezaznaczone pokażą obszary wymagające ostrożności lub dłuższej oceny.

- ☐ **Jakość relacji** — przynajmniej jedna dobra, wzajemna relacja w życiu
- ☐ **Motywacja do rozumienia** — „chcę zrozumieć”, nie tylko „proszę naprawić”
- ☐ **Refleksyjność** — zdolność spojrzenia na siebie z zewnątrz
- ☐ **Tolerancja afektu** — uniesie silne emocje bez załamania
- ☐ **Możliwość fokusu** — wyłania się jeden centralny konflikt

02 ✗ Wykluczenia względne

Te stany wymagają najpierw stabilizacji lub innego protokołu — nie wykluczają STPP na zawsze, lecz na ten moment.

- aktywna psychoza
- aktywne uzależnienie
- aktywne samouszkodzenia / ostre ryzyko
- ciężkie zaburzenie osobowości bez stabilizacji

03 Próbną interpretacja

W sesji 1-2 wskaż drobną obronę: „zauważyłam, że gdy dotykamy trudnego tematu, zaczyna Pani mówić o pogodzie”. Obserwuj reakcję: ciekawość i odkrycie → kandydat; załamanie, agresja, wycofanie → STPP nieodpowiednia teraz.

PRÓBNA INTERPRETACJA I REAKCJA PACJENTA

04 Decyzja

Na podstawie kryteriów i próbnej interpretacji wybierz drogę: STPP krótka, STPP długa, terapia dialektyczno-behawioralna lub schematów (ciężkie zaburzenia osobowości), terapia poznawcza (czyste objawy lękowe), inne.

DECYZJA I UZASADNIENIE

Klucz: nie rozstrzygaj kwalifikacji na podstawie jednej rozmowy — daj 2-3 sesje oceniające. Ale nie łam zasady, że STPP wymaga minimum zdolności: źle dobrany pacjent szkodzi obu stronom. Decyzja o skierowaniu gdzie indziej też jest dobrą opieką.